

MODUL LASKAR GIZI

PEMANTAUAN
PERTUMBUHAN
&
KONSELING
MAKAN

MAGISTER
KEBIDANAN



 POSYANDU
MAKARTI
PONDOK WALELO 2



Cegah Stunting
sejak dini!

Daftar Isi

satu topik, satu halaman (1/2)



✦ PEMBUKA

- 1 **Cover**
- 2 **Daftar Isi (1/2)**
- 3 **Daftar Isi (2/2)**
- 4 **Sasaran Modul**
untuk siapa modul ini dibuat
- 5 **Tujuan Modul**
yang diharapkan setelah membaca
- 6 **Cara Penggunaan Modul**
fleksibel dan praktis

✦ PERAN KADER & PEMANTAUAN

- 7 **Pesan Kunci Kader**
4 hal yang harus selalu diingat
- 8 **Apa Peran Kader?**
mendampingi, bukan menggantikan
- 9 **Apa yang Dipantau & Pertumbuhan Normal**
lihat grafik, bukan hanya angka
- 10 **Bagaimana Membaca KMS?**
5 langkah singkat kader
- 11 **Apa Arti N, T, 2T, dan BGM?**
tindak lanjut lebih penting dari label
- 12 **Kapan Kunjungan Rumah?**
untuk balita berisiko
- 13 **Kapan Harus Rujuk?**
lebih cepat lebih baik

Daftar Isi

satu topik, satu halaman (2/2)



✦ GIZI & PEMBERIAN MAKAN

- 14 **Apa Itu 1000 HPK?**
masa penting cegah stunting
- 15 **Apa Itu ASI Eksklusif?**
kegiatan 6 bulan
- 16 **Kapan Mulai MP-ASI?**
saat usia 6 bulan
- 17 **Berapa Porsi MP-ASI?**
usia 6–23 bulan mendapat ASI
- 18 **Contoh Menu MPASI Lokal**
bahan mudah didapat di Wonorelo
- 19 **Makanan Usia 1 Tahun+**
makanan keluarga bergizi seimbang
- 20 **Apa yang Dihindari?**
sebelum anak usia 1 tahun
- 21 **Jika Anak Sulit Makan atau GTM**
jangan panik, cari penyebabnya
- 22 **Tips Saat Sulit Makan**
praktis diterapkan di rumah
- 23 **Apa Itu Stunting?**
masalah gizi dini
- 24 **Gizi Kurang vs Gizi Buruk**
kenali bedanya sebelum merujuk

✦ KONSELING & PENUTUP

- 25 **Prinsip Konseling Kader**
kader yang mendukung
- 26 **5 Langkah Konseling & Contoh Dialog**
dialog untuk kader
- 27 **Checklist Kunjungan**
apa dan lakukan ini
- 28 **Biodata Penyusun**
tentang penulis modul ini
- 29 **Daftar Pustaka**
sumber resmi yang digunakan

" Tidak ada urutan yang salah. Buka halaman yang paling kamu butuhkan hari ini.



SASARAN MODUL

1. Kader Posyandu aktif yang bertugas di Posyandu Pondok Walelo 2.
2. Kader yang mengikuti kegiatan penyuluhan gizi dalam program pengabdian masyarakat.
3. Kader yang ingin memperkuat pemahaman tentang gizi balita, pemantauan pertumbuhan, dan konseling makan.
4. Kader yang ingin menggunakan modul ini sebagai panduan lapangan saat kunjungan rumah atau kegiatan posyandu.

TUJUAN MODUL



1. Mengetahui pesan kunci gizi balita, ASI eksklusif, MP-ASI, dan 1000 HPK.
2. Mengetahui cara memantau pertumbuhan balita menggunakan KMS dan menentukan status N, T, 2T, dan BGM secara tepat.
3. Mengetahui tanda-tanda awal anak berisiko gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
4. Mengetahui cara melakukan konseling sederhana kepada ibu balita tanpa menyalahkan atau menghakimi.
5. Mengetahui alur kunjungan rumah untuk balita 2T menggunakan checklist yang ada di modul.
6. Mengetahui kapan balita perlu dirujuk ke Puskesmas dan bagaimana menyampaikannya kepada ibu.

CARA PENGGUNAAN MODUL

1. Modul ini digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan kader Posyandu tentang gizi balita, pemantauan pertumbuhan, dan konseling pemberian makan.
2. Kader dapat membaca modul ini secara bertahap, sesuai topik yang ingin dipelajari.
3. Modul ini dapat digunakan saat kegiatan Posyandu, penyuluhan, diskusi kader, atau sebagai bahan belajar mandiri.
4. Setiap halaman berisi satu topik agar kader lebih mudah memahami isi materi.
5. Apabila kader menemukan balita dengan masalah pertumbuhan atau tanda risiko gizi, kader perlu melakukan pencatatan, konseling sederhana, dan menyampaikan kepada bidan atau petugas kesehatan.





PESAN KUNCI KADER

1. Mintalah IMD segera setelah bayi lahir agar bayi mendapat makanan pertama yang berkualitas
2. Bayi usia 0-6 bulan cukup diberi ASI saja, tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali obat/vitamin sesuai petugas kesehatan
3. MP-ASI mulai diberikan saat bayi berusia 6 bulan dari makanan keluarga berbahan lokal, dan ASI tetap dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih.
4. Pantau pertumbuhan setiap bulan melalui penimbangan, pengukuran, dan pencatatan di KMS/Buku KIA

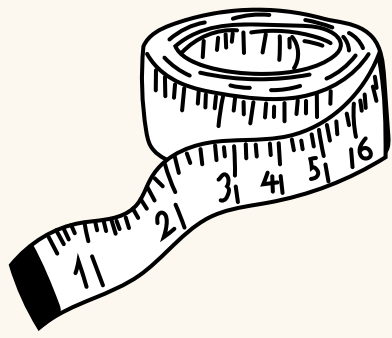
“ingat : kader itu mendampingi ibu, bukan menghakimi ya.



Apa peran Kader?

1. menjadi penggerak agar keluarga datang ke posyandu
2. menjadi penyuluh sederhana tentang gizi, ASI, MP-ASI dan perilaku sehat.
3. Menjadi pencatat sederhana hasil pemantauan balita.
4. Membantu menemukan masalah awal dan menghubungkan keluarga dengan bidan/petugas gizi puskesmas

“Kader bukan menggantikan tenaga kesehatan, tetapi membantu keluarga mendapatkan bantuan lebih cepat.”



Apa yang Dipantau?

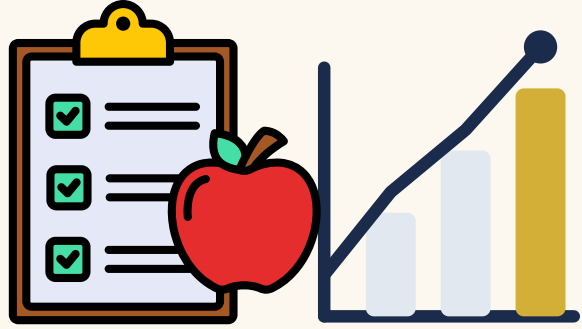
1. Berat badan anak
2. Panjang/ tinggi badan anak sesuai umur.
3. Perkembangan grafik di KMS/Buku KIA
4. Riwayat makan anak dan hambatan yang dialami Ibu.
5. Tanda anak perlu konseling, kunjungan rumah atau rujukan

“Bandingkan anak dengan grafik pertumbuhannya sendiri, bukan dengan anak lain.

Apa itu
Pertumbuhan
Normal?

1. Pertumbuhan dinilai dari perubahan berat dan tinggi anak dari waktu ke waktu
2. KMS/Buku KIA membantu kader melihat apakah garis pertumbuhan naik sesuai jalur.
3. Bila berat badan tidak naik, tetap turun, atau berada di bawah garis merah, kader perlu tindak lanjut



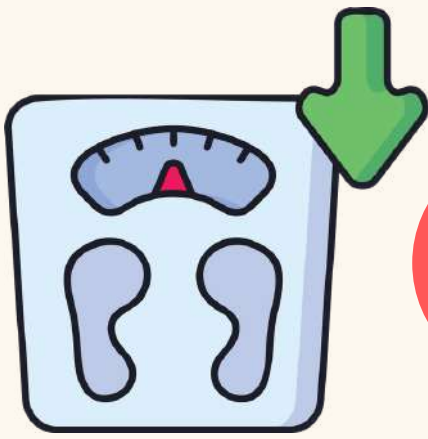


Bagaimana
Membaca KMS?

1. Cek identitas anak:
nama, umur, jenis kelamin
2. lihat berat badan bulan ini
dan bulan sebelumnya
3. Tandai titik berat badan
pada grafik sesuai umur
4. Hubungkan titik antar bulan,
lalu lihat arah garisnya.
5. Jelaskan hasilnya dengan
bahasa sederhana kepada
Ibu

“Gunakan kalimat mudah: “Bulan ini berat badan
naik/tidak naik, mari kita cari penyebabnya
bersama





Apa Arti N,T,2T,BGM?

status yang perlu diketahui

- **N:** berat badan naik dari bulan sebelumnya. Beri apresiasi kepada Ibu
- **T:** Berat badan tidak naik 1 bulan. Lakukan konseling dan pantau bulan berikutnya.
- **lihat berat badan bulan ini dan bulan sebelumnya**
- **2T:** berat badan tidak naik 2 bulan berturut-turut. Jadwalkan kunjungan rumah dan koordinasi dengan petugas kesehatan.
- **BGM:** berat badan berada di bawah garis merah. Rujuk/koordinasikan segera dengan Puskesmas.



Tindak lanjut lebih penting daripada hanya memberi label status.

Kapan Kunjungan
Rumah?



- Balita 2T atau berat badan tidak naik dua bulan berturut-turut.
- Ibu/keluarga jarang datang ke Posyandu
- Anak sulit makan berkepanjangan atau pola makan tidak teratur.
- Keluarga membutuhkan pendampingan untuk memahami KMS, PMBA, atau rujukan

“Saat kunjungan, jaga sikap ramah dan tidak menyalahkan keluarga.



Kapan Harus Rujuk?

- BGM atau dicurigai gizi buruk
- Berat badan turun atau tidak naik berulang meskipun sudah dikonseling.
- Anak tampak sangat kurus, lemah, lesu, dan sakit
- Ada tanda bahaya seperti demam, diare, muntahberulang, atau tidak mau minum/makan
- Kader ragu dengan kondisi anak.

“ Lebih aman berkonsultasi lebih cepat daripada menunggu kondisi memburuk.



Apa itu 1000 HPK?



- **1000 Hari Pertama Kehidupan dimulai sejak awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun.**
- **Masa ini penting karena kekurangan gizi dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.**
- **Pesan kader : Ibu hamil perlu gizi cukup, bayi 0-6 bulan ASI eksklusif, usia 6 bulan mulai MP-ASI dan ASI diteruskan**

“Cegah stunting dimulai sebelum anak lahir dan berlanjut sampai usia 2 tahun.



- ASI eksklusif berarti bayi hanya diberi ASI saja sampai usia 6 bulan.
- Tidak diberi air putih, madu, pisang, bubur, susu formula, atau minuman lain.
- Pengecualian hanya vitamin, mineral, dan obat-obatan sesuai petunjuk tenaga kesehatan

“ASI cukup untuk bayi 0-6 bulan. Bila ada masalah menyusui, arahkan ibu berkonsultasi



Kapan Mulai MP-ASI?

- MP-ASI mulai diberikan saat bayi berusia 6 bulan karena ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi.
- MP-ASI dibuat dari makanan keluarga berbahan lokal dan disesuaikan tekstur, frekuensi, serta jumlahnya menurut umur anak.
- ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih.

“MP-ASI bukan pengganti ASI, tetapi pendamping ASI



Berapa Porsi MP-ASI?



Panduan berikut diringkas dari tabel PMBA pada Buku Orientasi Kader Posyandu. Gunakan sebagai arahan umum dan tetap ikuti saran petugas kesehatan bila anak memiliki kondisi khusus.

Usia	Tekstur	Frekuensi & Jumlah
6-8 bulan	Bubur kental / makanan lumat	2-3 kali/hari. Mulai 2-3 sdm, naik bertahap sampai 1/2 mangkok 250 ml.
9-11 bulan	Dicincang halus / makanan yang dapat dipegang	3-4 kali/hari. Sekitar 1/2 mangkok 250 ml.
12-23 bulan	Masak biasa, Bahan makanan sama dengan orang dewasa. Tekstur makanan yg diris iris.	3-4 kali/hari. Sekitar 3/4 sampai 1 mangkok 250 ml.



Contoh Menu MP-ASI

Pastikan setiap porsi mengandung:
karbohidrat + protein hewani atau nabati + sayur atau buah.

Usia	Contoh Menu	Bahan Utama
6-8 bulan	Bubur beras + kuning telur + daun kelor, diblender halus	Beras, telur, kelor
6-8 bulan	Pure ubi kuning + kacang hijau rebus	Ubi, kacang hijau
9-11 bulan	Tim nasi + tahu halus + bayam cincang	Nasi, tahu, bayam
9-11 bulan	Bubur jagung + ikan lele cincang + wortel parut	Jagung, lele, wortel
12-23 bulan	Nasi + telur dadar + tumis daun kelor	Nasi, telur, kelor
12- 23 bulan	Nasi + semur hati ayam + sayur labu siam	Nasi, hati ayam, labu siam

“MPASI terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling sering diberikan dengan variasi yang cukup.



Makanan Usia 1 Tahun+



- Saat anak berusia 12 bulan, anak sudah dapat diberikan makanan keluarga.
- Pastikan makanan rumah sehat, beragam, dan bergizi seimbang.
- Makanan yang dibuat sendiri dari bahan segar di rumah lebih dianjurkan.
- Hindari membiasakan anak makan makanan instan dalam kemasan.

“Sajikan makanan keluarga dengan tekstur yang aman dan sesuai kemampuan anak.”



Makanan Apa yang Dihindari ?

- Hindari menambahkan garam dan gula.
- Hindari madu.
- Hindari susu sapi segar dan produk yang tidak dipasteurisasi.
- Hindari makanan yang berisiko tersedak seperti kacang utuh atau kismis.
- Hindari makanan yang mengandung merkuri tinggi.



Jika Anak Sulit Makan atau GTM

- Jangan panik dulu. Anak bisa menolak makan karena sudah kenyang atau sedang tidak enak badan.
- Amati kapan anak lapar dan kapan anak sudah cukup kenyang.
- Berikan variasi makanan pokok, lauk hewani/nabati, sayur, dan buah.
- Jika anak terlihat lesu atau sakit, arahkan ibu ke petugas kesehatan.



“Kader membantu mencari penyebab, bukan menyalahkan ibu.

Tips saat sulit makan

- Biasakan waktu makan yang konsisten.
- Duduk menghadap anak dan kurangi gangguan seperti TV/HP.
- Biarkan anak mencoba makan mandiri.
- Tidak memaksa atau memasukkan makanan ke mulut anak secara paksa.
- Beri pujian ketika anak mau makan.
- Konsultasikan ke Puskesmas jika anak masih sulit makan.



Bila anak marah atau menolak makan, hentikan sementara dan tawarkan kembali 2-3 jam kemudian



Gizi Kurang vs Gizi Buruk



	Gizi Kurang	Gizi Buruk
Di KMS	Di antara -2SD dan -3SD	Di bawah -3SD (zona merah/BGM)
Tampilan	Anak tampak kurus	Sangat kurus, kulit kendur, atau kaki/wajah bengkak
Kondisi	Masih aktif, bisa makan	Lemah, lesu, sulit makan
Tindakan Kader	Konseling gizi, pantau tiap bulan	Rujuk segera ke Puskesmas

“Jika ragu apakah gizi kurang atau gizi buruk, langsung koordinasikan dengan bidan atau petugas gizi. Jangan ditunda yaa

Prinsip Konseling Kader

- Dengarkan ibu lebih banyak sebelum memberi saran.
- Gunakan pertanyaan terbuka: “Apa yang biasanya terjadi saat waktu makan?”
- Validasi usaha ibu: “Ibu sudah berusaha, mari kita cari cara yang paling mungkin dilakukan.”
- Fokus pada satu masalah utama yang paling bisa diatasi keluarga.
- Hindari menyalahkan, membandingkan, atau menakut-nakuti.

“Konseling adalah percakapan dua arah, bukan ceramah panjang.



5 Langkah Konseling untuk Kader

1. Sapa ibu dengan ramah dan bangun suasana nyaman.
2. Tanyakan kondisi anak dan kebiasaan makan sehari-hari.
3. Dengarkan hambatan utama tanpa menghakimi.
4. Beri 1-2 saran yang sesuai kemampuan keluarga.
5. Sepakati rencana kecil dan waktu pemantauan berikutnya.

“Saran yang sedikit tetapi dilakukan lebih baik daripada banyak saran tetapi tidak dijalankan.”

Contoh Dialog

Kader: “Bu, boleh cerita biasanya anak makan jam berapa dan makannya apa saja?”

Ibu: “Kadang tidak mau makan, Bu.”

Kader: “Baik Bu, berarti kita cari dulu penyebabnya. Saat makan biasanya sambil menonton HP/TV atau tidak?”

Kader: “Untuk minggu ini, coba jadwal makan dibuat lebih teratur dan kurangi gangguan saat makan. Nanti kita pantau lagi ya, Bu.”



1. Bawa buku catatan/form kunjungan, KMS/Buku KIA, dan media edukasi sederhana
2. Ucapkan salam, perkenalkan diri, dan jelaskan tujuan kunjungan.
3. Tanyakan riwayat makan 3 hari terakhir dan hambatan saat makan
4. Amati jadwal makan, kebiasaan jajan/susu, dan gangguan saat makan.
5. Sepakati satu rencana kecil dan koordinasikan dengan bidan/petugas gizi bila perlu.



BIODATA PENYUSUN



**[Destiningsih Dini Safitri]
[Magister Kebidanan]
[Universitas Gadjah Mada]**



**[Fitri Fajarwati]
[Magister Kebidanan]
[Universitas Gadjah Mada]**



**[Putri Inez Indahningtyas]
[Magister Kebidanan]
[Universitas Gadjah Mada]**

Modul ini disusun berdasarkan pengalaman langsung mendampingi kegiatan Posyandu Pondok Walelo 2 serta mengacu pada panduan resmi Kementerian Kesehatan RI.

Untuk pertanyaan, saran, atau pengembangan modul lebih lanjut dapat menghubungi: 📞 [085820624984] ✉️ [laskargizi@gmail.com]

Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan RI. Buku Panduan Orientasi Kader Posyandu. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2019.
2. Kementerian Kesehatan RI. Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA): Buku Bacaan Kader Posyandu, Komunikasi Antar Pribadi, Pencegahan Stunting.
3. Kementerian Kesehatan RI. Kurikulum Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu, 2023.
4. Modul awal: Gizi Balita, Pemantauan Pertumbuhan & Konseling Pemberian Makan, Posyandu Pondok Wonolelo 2.
5. WHO. Child Growth Standards sebagai acuan pemantauan pertumbuhan anak.



Untuk dapat mengakses modul ini, kamu bisa scan barcode dibawah ini yaa

